

Анализ рынка: платформа навигации по медицинским доказательствам

Кто уже это делает, как они на этом зарабатывают и где остаётся реальная ниша

Подготовлено: Joseph, MN&J Labs · 6 августа 2026 · Редакция 3 (добавлены английский, русскоязычный и европейский сегменты) · Источник данных: открытый веб — 14 поисковых запросов и прямые загрузки страниц. Все факты ниже проверены по указанным ссылкам в этот день; там, где проверить не удалось, это сказано прямо.

Вывод

Врачебная половина идеи закрыта. OpenEvidence бесплатен для врачей, живёт на фарм-рекламе, встроен в Epic и ежедневно используется примерно **40% врачей США** при оценке **12 млрд \$**.

Англоязычная пациентская половина закрывается прямо сейчас. 12 марта 2026 года OpenEvidence и NORD объявили о партнёрстве: библиотека **3000+ описаний редких заболеваний**, в версиях **и для врачей, и для пациентов**, с **экспертной проверкой людьми** и ежемесячным обновлением. Это и есть архитектура нашей спецификации — ИИ-синтез плюс человек-рецензент плюс регулярное обновление, — реализуемая компанией с оценкой 12 млрд \$, бесплатно.

Но остаётся то, чего не делает никто: связать доказательство с ответом на вопрос «а доступно ли это мне там, где я живу». Это и есть наша ниша — и она одна и та же для английского и для русского/иврита.

Кто уже на рынке — по силе столкновения с нами

№	Игрок	Что это	Масштаб	Деньги
1	Outcomes4Me	Персонализированные варианты лечения, подбор исследований, опора на NCCN Guidelines, курируемые новости науки по диагнозу	300 000+ пациентов, 12+ видов рака	21 млн \$; партнёрства с Life Sciences
2	Belong.Life (Израиль)	Соцсеть онкопациентов + ИИ-наставник «Dave» (валидирован онкологами ASCO/ESMO) + «Tara» — подбор клинических исследований	1 млн+ пользователей, 100+ стран	Series B 14 млн \$, лид — IQVIA
3	OpenEvidence	ИИ-поиск по доказательствам для врачей, встроен в Epic	~40% врачей США ежедневно; 10 000+ больниц	Series D 250 млн \$, оценка 12 млрд \$; ~150 млн \$ ARR (оценка Sacra)
4	Massive Bio	ИИ-подбор онкологических клинических исследований	200 000+ пациентов, 19 000+ исследований	Партнёрство с FOMAT, июнь 2026

№	Игрок	Что это	Масштаб	Деньги
5	EvidenceAlerts (McMaster)	Оповещения о доказательствах из 100+ журналов с оценкой людьми-врачами	Академический проект, только для врачей	Бесплатно
6	Consensus / Elicit / Scite	ИИ-поиск по научной литературе	Общий research	10–12 \$/мес (Elicit Pro 49 \$)

Где именно мы проиграем

Outcomes4Me — они это уже делают. Персонализация по диагнозу, опора на NCCN, подбор исследований, научные обновления, 300 тыс. пациентов и интеграция с тем самым источником руководств, который нам пришлось бы лицензировать. Вопрос пациента: зачем мне переходить?

Belong.Life — вот это должно беспокоить Наума больше всего. Израильская компания, 1 млн пользователей, ИИ, валидированный онкологами, и IQVIA (крупнейшая в мире компания по клиническим данным) в роли лид-инвестора. Они занимают ровно ту географию и ровно то сообщество, на которое целился наш мультязычный заход.

OpenEvidence — выиграть нечего. Продукт **бесплатен** для врачей и живёт на фарм-рекламе с CPM 70–1000+ \$ на аудиторию ~600 тыс. выписывающих врачей США (~124 \$ ARPU). Любой платный врачебный тариф с нашей стороны конкурирует с бесплатным и более сильным продуктом. Пациентского продукта у них на сегодня **не найдено** — это и есть окно. Но компания с такой оценкой может войти в этот сегмент когда захочет.

EvidenceAlerts — самый поучительный конкурент. McMaster много лет ведёт оповещения о доказательствах с ручной оценкой врачами. Проект остался бесплатным, академическим и только для врачей. Никто не превратил это в потребительский бизнес. Это сигнал о готовности платить, а не незамеченная всеми ниша.

Английский сегмент — что изменилось

Поправка к предыдущей версии анализа. В первой редакции я написал: «пациентского продукта у OpenEvidence не найдено — это и есть окно», отдельно оговорив, что отсутствие свидетельств не есть свидетельство отсутствия. Проверка англоязычного сегмента показала, что окно уже закрывается. Исправляю прямо, потому что это меняет вывод.

NORD + OpenEvidence, объявлено 12 марта 2026. Что именно они строят:

- **3000+ сводок по редким заболеваниям**, обновляемых **ежемесячно** через редакционную систему
- Две версии каждой сводки — **для врача и «понятным языком» для пациента и семьи**
- **Экспертная проверка** специалистами, рекомендованными NORD, включая сеть NORD Rare Disease Centers of Excellence
- Пациентские версии распространяются через партнёрские каналы; врачебные — внутри платформы

Иначе говоря: **ИИ-синтез + человек-рецензент + регулярное обновление + понятный пациенту формат** — это дословно наша архитектура. Её строит компания с оценкой 12 млрд \$, бесплатно, на английском, в масштабе 3000 заболеваний. Конкурировать с этим «в лоб» на английском невозможно: ни по деньгам, ни по доступу к экспертам, ни по скорости.

Чего они всё равно не делают

- **Это библиотека, а не персональное наблюдение.** Сводка по заболеванию, обновляемая раз в месяц, отвечает на вопрос «что известно о болезни». Она не отвечает на вопрос «что изменилось лично для меня с момента моего диагноза».
- **Это США.** Одобрение и — главное — **оплата** лечения различаются по странам. Даже внутри Великобритании: Англия (NICE + Cancer Drugs Fund, до 340 млн £ в год), Шотландия (SMC), Уэльс (AWMSG + New Treatment Fund), Северная Ирландия — четыре разных ответа на один вопрос. Сегодня пациент собирает это по сайтам благотворительных фондов и государственных органов.
- **NORD — это редкие заболевания.** Англоязычная онкология для пациентов — территория Outcomes4Me (США, 300 тыс. пациентов, NCCN).

Русскоязычный сегмент

Это была моя главная непроверенная гипотеза — я прямо писал, что на ней держится весь замысел. Проверил. **Игрок есть.**

«Просто спросить» — бесплатная онлайн-справочная фонда медицинских решений **«Не напрасно»**, запущена 4 февраля 2019 года. Консультации ведут онкологи, прежде всего выпускники **Высшей школы онкологии**. Фонд с 2010 года продвигает принципы **доказательной медицины**. Пациент задаёт вопрос о диагнозе, корректности схемы лечения, необходимых обследованиях — и получает ответ врача.

Что это значит. В русскоязычном пространстве уже есть доверенный бренд с правильной этикой и — что важнее всего — **с доступом к онкологам-рецензентам**, то есть к тому самому ресурсу, который мы определили как узкое место всего проекта.

Но это другой продукт. «Просто спросить» — это справочная: человек задаёт вопрос, человек отвечает. Это не система наблюдения («что изменилось с момента моего диагноза») и не справочник доступности («могу ли я это получить там, где живу»). Модель не масштабируется по объёму — она масштабируется по числу врачей.

Отсюда вывод, который стоит обдумать всерьёз: это скорее партнёр, чем конкурент. У них доверие и врачи, у нас — конвейер. Конкурировать с бесплатной службой уважаемого фонда и тяжело, и незачем.

Отдельно про географию: обслуживание пользователей внутри России добавляет платёжные, санкционные и юридические сложности. Реально адресуемая аудитория — **русскоязычная диаспора**: Израиль, Германия, Прибалтика, США. Это же снимает часть регуляторных вопросов.

Европейский сегмент

Здесь два факта, и второй важнее первого.

1 · Сильные игроки есть, и они государственные

В Германии IQWiG с 2006 года ведёт сайт **gesundheitsinformation.de** (и англоязычный **informedhealth.org**) — доказательные материалы для пациентов, бесплатно, в рамках законодательного мандата института информировать население. Материалы объясняют преимущества и недостатки основных вариантов лечения. Аналогичные национальные ресурсы есть и в других странах ЕС.

Но это снова **библиотека тем**, а не персональное наблюдение, и — главное — она не отвечает на вопрос о доступности и оплате конкретного лечения.

2 · Регуляторный сдвиг работает на нас

Регламент ЕС по оценке медицинских технологий (HTAR) вступил в силу **12 января 2025 года** — и первыми под него попали **онкологические препараты** и передовые виды терапии.

Совместная клиническая оценка (Joint Clinical Assessment) делается **один раз на уровне ЕС**. Но регламент **прямо не покрывает** экономическую оценку, ценообразование и возмещение — **эти решения остаются за каждой страной**.

Редкие заболевания добавляются в 2028 году, все остальные — в 2030-м.

Прочитайте это ещё раз с точки зрения пациента. Начиная с 2025 года по новому онкопрепарату существует **один** общеевропейский клинический ответ — и **двадцать семь** разных ответов на вопрос «оплатят ли мне это». Регламент не устраняет этот разрыв, он делает его заметным и документированным.

Иначе говоря, Европа своими руками создаёт ровно ту задачу, которую решает наш продукт: доказательства унифицируются, доступ — нет. И объём этой задачи по графику будет только расти: 2028-й, затем 2030-й.

Находка, которая меняет стратегию

Все, кто вырос на этом рынке, финансируются фармой:

- **OpenEvidence** — фармацевтическая реклама
- **Outcomes4Me** — партнёрства с Life Sciences
- **Belong.Life** — раунд под лидерством IQVIA

Наша спецификация делает «никакой ложной надежды» и «доказательства прежде вовлечения» непреложными принципами. **Эти принципы исключают единственную модель дохода, которая здесь у кого-либо заработала.**

Это не деталь, которую можно решить позже, — это центральная стратегическая проблема. Либо проект находит плательщика, которого не нашёл никто, либо компрометирует принцип, ради которого его стоит делать.

И вот ответ, который дала проверка русского и европейского сегментов

В США всё, что выросло, выросло на деньгах фармы. Но в России и Европе картина **прямо противоположная**: «Просто спросить» — благотворительный фонд, gesundheitsinformation.de — государственный институт. Оба бесплатны для пациента. Оба существуют годами.

Из этого следуют два вывода сразу, и они тянут в разные стороны:

- **Плохая новость**: готовность платить у пациента близка к нулю. Он привык, что такая информация бесплатна, потому что её финансирует фонд или государство. Продавать подписку пациенту в этих рынках почти безнадежно.
- **Хорошая новость**: **плательщик — это учреждение, а не пациент**. Фонды, национальные онкологические общества, государственные институты и — в Израиле — больничные кассы уже финансируют ровно эту работу. Им нужен наш конвейер; у них есть доверие, рецензенты и бюджет.

Отсюда рекомендуемая модель — **не D2C-подписка, а B2B2C через пациентские организации**: мы даём движок (мониторинг доказательств + справочник доступности), они дают бренд, врачей-рецензентов и финансирование. Это единственная модель, которая одновременно сохраняет принцип «никакой ложной надежды», не требует денег фармы и не пытается продать подписку испуганному человеку.

Ниша: два рынка, один движок

Проверяемое утверждение: все существующие игроки отвечают на вопрос «*что известно об этой болезни*». Никто не отвечает на вопрос «*доступно ли это лечение мне — там, где я живу, и кто за него платит*».

Различие не в языке. Различие в **юрисдикции**. Поэтому английский и русский/иврит — это не выбор «или-или»: это один и тот же продукт с разными справочниками доступа.

Сегмент А — английский, по юрисдикциям

Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия. Доказательства везде одинаковы, а **оплата — нет**. В одной только Великобритании четыре разных механизма (NICE/CDF, SMC, AWMSG, Северная Ирландия), и пациент сегодня собирает ответ по сайтам фондов. Американские игроки этим не занимаются: их рынок — США.

Почему защитимо: это скучная, локальная, постоянно меняющаяся работа по сведению регуляторных данных — ровно то, чего не станет делать компания, растущая на рекламных CPM в США.

Сегмент Б — русский и иврит, Израиль

В Израиле арабоязычные составляют ~24%, русскоязычные ~17% населения, а нынешнее обеспечение для них — уровня НКО: Израильская ассоциация борьбы с раком вела грантовый проект с переводом материалов, волонтерскими группами и телефонной горячей линией; ESMO и Американское онкологическое общество публикуют переводные PDF-брошюры. Это листовки и телефон, а не продукт.

И главное: «корзина здоровья» (סל תרופות) — то, что реально оплачивается государством, — это тот же самый справочник доступа, только для Израиля. Тот же движок, другая таблица.

Почему это одна работа, а не две

Конвейер доказательств (сбор → нормализация → оценка уровня → проверка человеком) строится один раз и общий для всех рынков. Разными остаются только два слоя: **таблица доступа по юрисдикции** и **язык вывода**. Это означает, что английский сегмент не конкурирует с израильским за ресурсы — он использует ту же систему. Начать дешевле с одной юрисдикции, а какой именно — вопрос того, где быстрее найдётся рецензент.

Чего я не смог проверить

- **Цены Outcomes4Me** — на сайте не указаны; бесплатность для пациента подразумевается, но не подтверждена.
- **Бюджет и объём «Просто спросить»** — сколько обращений в месяц и сколько врачей задействовано, публично не нашёл. Для оценки партнёрства это ключевые цифры.
- **Ивритоязычный игрок** — проверен только косвенно. Прямой поиск на иврите я не вёл; это остаётся открытым.
- **Выручка Belong.Life и их доля в Израиле** — цифры не публикуются.
- **Национальные аналоги IQWiG** во Франции, Италии, Испании и Польше — не проверял поштучно; предполагаю, что они есть, но это **предположение, а не факт**.
- **Есть ли готовые машиночитаемые данные о возмещении** по странам ЕС — не проверял. Если таких данных нет, «справочник доступности» придётся собирать вручную, и это **меняет оценку трудоёмкости всего проекта**. Проверить до планирования.

Рекомендация

Глобальная платформа на десять фаз из спецификации против этого поля не жизнеспособна. Соревноваться с OpenEvidence в «сводках по заболеванию» — тоже. Но защитимый первый продукт есть, и он один для обоих рынков:

Доказательства + доступ. Оценённые по уровню и проверенные человеком данные по одной нозологии, где каждая карточка отвечает на два вопроса: *что изменилось* и *могу ли я это получить там, где живу*.

Одна нозология · одна юрисдикция для старта · сначала веб · еженедельный дайджест.

Это достаточно мало, чтобы построить имеющейся командой; достаточно скучно и локально, чтобы туда не пошли ни OpenEvidence, ни Outcomes4Me; и достаточно честно, чтобы сохранить стержень «никакой ложной надежды» — потому что «вам это недоступно» тоже честный ответ, и сегодня его никто не даёт.

До начала работ — три действия:

1. **Поговорить с «Не напрасно»** (и с одной европейской пациентской организацией). Не продавать — спросить: «вам нужен мониторинг доказательств и справочник доступности, и кто бы это оплатил?». Один разговор проверяет и продукт, и модель дохода сразу.
1. **Проверить, существуют ли машиночитаемые данные о возмещении** хотя бы по двум странам. Если нет — вся оценка трудоёмкости меняется.

1. **Выбрать стартовую юрисдикцию по рецензенту**, а не по размеру рынка: начинаем там, где первым согласится конкретный онколог.

Обратите внимание: ни одно из трёх действий не требует написать ни строки кода. Это и есть правильный порядок — сначала рецензент и плательщик, потом конвейер.

Отдельно: название проекта

Против варианта «Light of Hope» / «Свет надежды» — два конкретных возражения, не вкусовых.

1 · Оно обещает ровно то, что продукт отказывается продавать

Первый непреложный принцип спецификации — «никакой ложной надежды». Весь этический стержень: доказательства прежде вовлечения, ничего не преувеличивать, человек-рецензент перед тем, как что-то дойдёт до пациента. Название «Свет надежды» подрывает это прямо на входной двери — оно создаёт то самое ожидание, ради управления которым продукт и существует. Для напуганной аудитории это не ирония, а режим отказа. И это первое, что критик или регулятор процитирует в ответ.

2 · Имя уже занято — в этой же категории

Lights of Hope — флагманская кампания Американского онкологического общества (ACS CAN): более 14 лет, по всей стране, ~65 000 памятных пакетов в год, действует и в 2026-м. Запуск онкологического продукта под этим именем означает конкуренцию с ACS за собственную поисковую выдачу.

Что должно уметь название

- Не обещать исход — это навигационный инструмент, а не лечение (и это же граница SaMD)
- Работать на русском и на иврите — это наш целевой рынок
- Говорить, что продукт делает: ориентация и источники
- Быть различимым в категории, перегруженной словами «надежда» и «путь»

Название	Значение	Почему работает	Риск
Makor מקור · Макор	ивр. «источник, первоисточник»	Вся дисциплина продукта — «у каждого утверждения есть источник». Плюс «источник» в журналистском смысле — достоверность. Звучит местно и заслуживающе доверия в Израиле; русскоязычные произносят легко.	Частое слово; «Макор Ришон» — крупная израильская газета
Orientir Ориентир	рус. «точка, по которой ориентируются»	Буквально функция продукта — не пункт назначения, а точка отсчёта. Занимает русскоязычную нишу.	Ничего не значит для англо- и ивритоязычных
Beacon маяк · מגדלור	«маяк»	Сохраняет образ света, который вам понравился, но убирает обещание: маяк показывает, где вы находитесь, и никогда не обещает, что вы дойдёте до берега.	«Beacon Health» широко занято в американском health-tech

Моя рекомендация — Makor (Макор). Это единственный вариант, который называет дисциплину, а не чувство, — а дисциплина и есть продукт. Он местный для того рынка, с которого мы реально начнём, и даёт обещание, которое мы способны сдержать: *за каждой строкой здесь стоит источник.*

Makor — онкологические доказательства: источник и проверка.

Если хочется сохранить метафору света — **Beacon** это честная её версия. Если ставим флаг именно в русскоязычной общине — **Ориентир**.

Оговорка: это суждение о названии, а не юридическая проверка. Товарные знаки и домены я не проверял.

Источники

Все ссылки открыты и проверены 6 августа 2026 года.

- CNBC — OpenEvidence, оценка 12 млрд \$:
cnbc.com/2026/01/21/openvidence-chatgpt-for-doctors-doubles-valuation-to-12-billion.html
- Fierce Healthcare — Series D 250 млн \$:
fiercehealthcare.com/ai-and-machine-learning/openvidence-clinches-250m-series-d-rapidly-growing-its-reach-doctors
- NBC News — кто будет платить за OpenEvidence:
nbcnews.com/tech/tech-news/openvidence-free-now-ceo-plan-will-pay-rcna343672
- Sacra — выручка и оценка OpenEvidence: sacra.com/c/openvidence/
- Outcomes4Me — сайт продукта: outcomes4me.com
- Belong.Life — Series B 14 млн \$: belong.life/press/belong-life-raises-14-million-to-expand-its-digital-cancer-support-network/
- Fierce Healthcare — ИИ-наставник Belong.Life:
fiercehealthcare.com/digital-health/belonglife-maker-social-network-cancer-patients-launches-ai-mentor
- Massive Bio — сайт и партнёрство с FOMAT: massivebio.com ·
biospace.com/press-releases/massive-bio-partners-with-fomat-to-expand-cancer-patient-prescreening-for-clinical-trial-access
- EvidenceAlerts (McMaster): medlib.belmont.edu/keepcurrent/evidencealerts
- UICC — арабо- и русскоязычные пациентки в Израиле:
uicc.org/case-studies/support-groups-arab-and-russian-speaking-women-metastatic-breast-cancer-israel
- ACS — информация об онкологии на русском: cancer.org/cancer-information-in-other-languages/russian.html
- PR Newswire — партнёрство NORD и OpenEvidence, 12.03.2026: prnewswire.com/news-releases/national-organization-for-rare-disorders-and-openvidence-partner-to-bring-ai-powered-rare-disease-resources-to-clinicians-and-patients-worldwide-302711679.html
- NORD — страница партнёрства: rarediseases.org/national-organization-for-rare-disorders-and-openvidence-partner-to-bring-ai-powered-rare-disease-resources-to-clinicians-and-patients-worldwide/
- NHS England — Cancer Drugs Fund: england.nhs.uk/cancer/cdf/
- Cancer Research UK — как лекарства попадают в NHS:
cancerresearchuk.org/about-cancer/treatment/access-to-treatment/how-medicines-become-available
- Target Ovarian Cancer — как одобряют онкопрепараты в разных частях Великобритании:
targetovariancancer.org.uk/get-involved/campaign/current-campaigns/access-drugs/how-are-cancer-drugs-approved-across-uk
- Фонд «Не напрасно» — служба «Просто спросить»: nenaprasno.ru/projects/prosto-sprosit/ · ask.nenaprasno.ru
- Европейская комиссия — совместные клинические оценки (JCA): health.ec.europa.eu/health-technology-assessment/implementation-regulation-health-technology-assessment/joint-clinical-assessments_en
- EURORDIS — что меняется в HTA с 2025 года: eurordis.org/what-happens-hta-2025/
- OHE — разбор европейской совместной клинической оценки:
ohe.org/insights/one-europe-one-assessment-unpacking-the-european-joint-clinical-assessment/
- IQWiG — отдел информации о здоровье и сайт gesundheitsinformation.de:
iqwig.de/en/about-us/institute-structure/departments/health-information/ · informedhealth.org/about-us/informedhealth/

- ACS CAN — кампания Lights of Hope: fightcancer.org/lights-hope-1
- Сравнение цен Elicit / Consensus: paperguide.ai/blog/elicit-vs-consensus/